

**La relation d'aide dans la prise en charge infirmière d'un
patient stomisé présentant une altération de l'image
corporelle**

Travail de Fin d'Etudes présenté
pour l'obtention du grade académique de
Bachelier : Infirmier Responsable de soins généraux
par

COP Fanny
Juin 2022

Remerciements

Je tiens à remercier ma promotrice, Madame Marteau pour son soutien, sa patience et ses précieux conseils. Mes remerciements s'adressent également à

Sonia Grégoire pour sa relecture, et l'infirmière stomathérapeute pour son partage d'expérience.

Une pensée particulière va à Nancy et Charlotte, sans qui je pense ces années auraient été bien tristes et difficiles.

Et pour terminer, je remercie ma famille et spécialement Guillaume pour leur soutien et leur patience, sans qui la réussite n'était pas possible.

Image corporelle perturbée

Deuil

Relation d'aide

Table des matières

Introduction	5
1. Constat(s), interpellation(s) et ancrage à la discipline infirmière	6
1.1 Le Constat et l'interpellation	6
1.2 Ancrage	8
1.2.1 La loi.....	8
1.2.2 Référence aux compétences professionnelles BIRSG.....	9
1.3 Énoncer les concepts clés	10
2. Recherches et réflexion professionnalisante.....	12
2.1 Exploration des concepts	12
2.1.1 L'image corporelle perturbée	12
2.1.2 Le deuil.....	14
2.1.3 La relation d'aide	16
2.2 La recension des écrits	18
2.3 L'enquête exploratoire avec une personne-ressource	25
3. Synthèse, questionnement professionnel et pistes de réflexion.....	29
Conclusion personnelle	32
Liste de références.....	34

Introduction

Pour la réalisation de ce travail de fin d'étude, il nous était demandé de partir d'une situation vécue en stage et ayant entraîné un questionnement personnel, donnant lieu, par la suite, à une recherche scientifique et une analyse.

Le passage en hôpital peut être une étape difficile pour les patients. Cela est d'autant plus le cas si une modification corporelle a lieu au cours de cette hospitalisation (stomie, amputation, cicatrice ...). J'ai été particulièrement touchée par une personne ayant une faible image d'elle-même et qui était en demande d'aide. J'ai souhaité développer les interventions de l'infirmière quant à des patients qui ont une image corporelle altérée.

Dans ce mémoire, j'analyse les concepts d'image corporelle altérée, mais aussi ceux du deuil ainsi que la relation d'aide de l'infirmière vis-à-vis des patients. Ces trois éléments permettent de poser un cadre théorique sur un diagnostic infirmier qui concerne ma situation vécue, ainsi que sur le type de relation qui en découle pour l'infirmière.

Ensuite, j'ai analysé quelques articles de littérature scientifique afin d'apporter un éclairage sur la thématique de la relation d'aide de l'infirmière dans de telles circonstances. Pour ce faire, je me suis d'abord concentrée sur les conséquences psychologiques de la stomie et ensuite j'ai abordé l'intervention de l'infirmière dans la relation d'aide au patient stomisé.

Finalement, cette analyse me permet d'arriver à un nouveau questionnement professionnel et à des pistes de réflexion.

1. Constat(s), interpellation(s) et ancrage à la discipline infirmière

1.1 Le Constat et l'interpellation

Lors de mon stage dans un service de chirurgie générale, j'ai pris en charge une patiente âgée d'une cinquantaine d'années, présentant une grande dépression. Lors d'une énième tentative de suicide, madame s'est donné des coups de couteau dans le ventre. À la suite de quoi, une opération a été effectuée en urgence engendrant une colostomie et une iléostomie. Précédemment, madame avait déjà une colostomie définitive suite à un autre geste envers elle-même. La patiente présente donc trois stomies. Madame est connue du service pour les interventions précédentes. En ce qui me concerne, c'était la première fois que je la rencontrais.

Lors de ma journée de travail, madame revient de son opération dans le courant de l'après-midi. L'équipe et moi-même constatons que cette patiente demande beaucoup d'attention. Les appels sont permanents, madame demandant à boire constamment. Nous lui expliquons à tour de rôle que nous ne pouvons répondre favorablement à sa demande et qu'il faut attendre quelques heures après l'opération. Les portes des chambres sont toujours ouvertes dans le service et madame regarde constamment vers le couloir. Nous avons vraiment l'impression que la patiente réclame de l'attention et de la présence.

Ensuite, fin de journée, je me rends à nouveau dans sa chambre pour répondre une nouvelle fois à sa demande. J'en profite pour lui administrer son antibiotique et réaliser les soins du soir.

Lorsque je suis entrée dans sa chambre, madame cherchait sans cesse mon regard, je le ressens insistant et implorant. Après les formalités de présentation, l'administration de l'antibiotique, je propose de la réinstaller. Elle me redemande à boire et je lui explique à nouveau.

Ensuite, la patiente se confie sur son état. *« Ça me dégoûte de voir la merde là sur mon ventre, c'est horrible »* (dixit). À cet instant, je n'ai pas su quoi lui répondre. Je lui ai tout de même dit : *« Je comprend ce ne doit pas être facile pour vous »*. Madame n'était pas apaisée, son regard était grave, les poings serrés.

Je connais la difficulté que les patients ont à faire face à une modification corporelle importante, mais j'ai été fortement décontenancée par ses paroles. Ce qui a été difficile pour moi n'est pas de comprendre son propos, mais de pouvoir réagir adéquatement. J'aurais voulu apporter des pistes ou du moins une ébauche de pistes vers le deuil et l'acceptation de son

corps, mais j'en étais incapable. Madame n'a pas insisté plus et nous avons terminé la conversation sur ces quelques derniers mots.

Au vu de la situation, il me paraît primordial de pouvoir circonscrire la problématique du patient en posant un diagnostic infirmier d'image corporelle perturbée. Selon Pascal et Frecon Valentin, cela se définit par une « confusion dans la représentation mentale du moi physique ». (2016, p.281)

Madame X présente les caractéristiques suivantes :

- Altération d'une structure ou d'une fonction corporelle ;
- Sentiment négatif vis-à-vis de son corps ;
- Réaction non verbale à un changement corporel réel ou perçu, c'est-à-dire par son visage tendu, ses mains crispées ;
- Expression de sentiments reflétant une altération dans la représentation de son image corporelle

Ce diagnostic trouve sa source dans les facteurs favorisants suivants :

- Altération d'une fonction corporelle due au traumatisme de sa tentative de suicide
- Le traumatisme lié à son acte.
- Le trouble de fonction psychosocial : la patiente a tenté de mettre fin à ses jours.

Durant ma prise en charge, je me suis sentie décontenancée par l'appel à l'aide de la patiente. Je ne me sentais pas suffisamment armée pour l'aider. Dans mon idéal professionnel, je souhaitais pouvoir lui apporter des pistes afin de cheminer dans son deuil.

Dès lors, je suis interpellée par l'accompagnement de l'infirmière envers un patient avec une modification corporelle conséquente. Mon intérêt se porte donc sur la relation d'aide apportée à un patient ayant une image corporelle perturbée dans le but d'améliorer le rapport à son corps. Dans la situation, nous nous trouvons dans un service aigu. Il ne sera donc pas possible d'accompagner en vue d'aider et d'encadrer le patient dans tout son processus de deuil, mais bien d'amorcer le cheminement vers la résilience. Je suis donc curieuse de comprendre l'accompagnement assuré par l'infirmière dans ce contexte. Finalement, cette dernière devra faire le lien avec les infirmiers qui pourront prendre le relai dans un cadre extrahospitalier afin de poursuivre le deuil.

1.2 Ancrage

1.2.1 La loi

Mon rôle d'infirmière vis-à-vis de cette thématique s'inscrit dans la Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (Moniteur Belge, 2021), et plus précisément à l'article 46.

§1°. On entend par exercice de l'art infirmier, l'accomplissement des activités suivantes.

1° a) Observer, identifier et établir l'état de santé sur les plans psychique, physique et social ;

b) Définir les problèmes en matière de soins infirmiers ;

...

e) Assurer assistance continue, accomplir des actes ou aider à leur accomplissement en vue du maintien, de l'amélioration et du rétablissement de la santé des personnes et de groupes qu'ils soient sains ou malades.

La thématique choisie s'inscrit bien dans la loi relative au rôle infirmier. En effet, les soins relationnels fournis par l'infirmière reposent avant tout sur un constat de base concernant le patient. Afin de pouvoir fournir un accompagnement de qualité, nous devons observer le bénéficiaire de soin afin de déterminer quels sont ses réels besoins, ses problèmes et ses attentes.

Ensuite vient s'inscrire l'ensemble de la démarche clinique qui en découle, à savoir de pouvoir en identifier les problèmes qui relèvent du rôle infirmier. Dans la situation présentée, les caractéristiques identifiées par la patiente permettent de poser un diagnostic d'image corporelle perturbée.

Dans la suite de la démarche clinique, l'infirmière fournit un soutien en posant des interventions infirmières, dans ce cas il s'agit de soins relationnels dans le but d'aider le patient à recouvrer son état de santé mentale. La difficulté dans la situation présentée étant de pouvoir mettre en place des soins relationnels afin d'aider la patiente dans sa détresse psychologique.

Selon l'article 9 du code de déontologie, l'infirmière a l'obligation de faire part des éléments concernant le patient en le faisant figurer dans le dossier infirmier. (2017, p.5) L'intérêt pointé par cet article est bien de pouvoir faire les liens entre les différents professionnels de la santé.

Ces transmissions permettent donc de prendre en charge efficacement les patients. Dans un service de chirurgie, le passage des patients est relativement bref. Par conséquent, les soins relationnels posés par l'infirmière lors de ce séjour le seront également. Sa tâche est donc une sorte d'amorce à un travail de plus longue durée. Afin de pouvoir permettre au patient de cheminer et de ne pas se sentir abandonné dans la prise en charge à sa sortie, il semble utile de pouvoir relayer ce qui a été réalisé (objectif du patient, difficultés ...).

Art. 9. L'infirmier transcrit les données infirmières concernant les bénéficiaires de soins dont il a la charge de façon objective, neutre et concise dans un dossier infirmier.

>> dossier infirmier INAMI

>> AR contenu du dossier infirmier hospitalier

>> Dossier informatisé partagé (Wallonie, Bruxelles) et ehealth

Le dossier infirmier peut être consulté par le bénéficiaire et d'autres personnes compétentes ou d'autres professionnels selon les règles de la loi relative aux droits du patient.

L'infirmier donne ses soins au bénéficiaire dans une relation de respect et de confiance mutuels. Il écoute le bénéficiaire de façon active, il répond de façon adéquate à ses questions et il assure une observation continue de l'évolution de l'état de santé du bénéficiaire ainsi qu'un coaching. (2017, p.6).

Selon cet article 10 de ce code, l'infirmier devra créer une relation de confiance permettant de l'aider à cheminer vers un mieux-être. Son observation permettra d'intervenir dans l'évolution de son état de santé.

Dans la situation vécue, j'ai observé un mal-être de la patiente, grâce à ses paroles, mais aussi à son langage non verbal. Madame avait besoin de se confier et que j'entende sa douleur. Un minimum de confiance sera nécessaire pour l'aider.

1.2.2 Référence aux compétences professionnelles BIRSG

La situation vécue et l'interpellation qui en découle font référence à plusieurs compétences énumérées dans le référentiel de compétences. (Haute école Robert Schuman, 2021)

Au sein de la compétence 4, les capacités 4.2 à 4.5 sont concernées par l'objet de ce travail, car elles font référence à l'ensemble de la démarche clinique nécessaire à la prise en charge de la patiente.

Premièrement, il était important de pouvoir délimiter le problème de la patiente en posant un diagnostic infirmier sur base des caractéristiques observées favorisées par différents facteurs. Il s'agit donc de la compétence 4.2 « Identifier les situations de santé, les diagnostics infirmiers et les problèmes traités en collaboration ».

Lors de la prise en charge de la patiente, nous agissons dans le but d'atteindre un résultat. Dans la situation, les soins relationnels ont un objectif sur le bien-être psychique de la personne. Ce point fait donc référence à la compétence 4.3 « Fixer les résultats attendus ».

Ensuite, l'infirmière devra agir en posant des interventions (4.4 « Prescrire les interventions de soins »). Finalement, les soins prodigués produisant un effet sur le patient seront à évaluer, suivant la compétence 4.5 « Évaluer la démarche et les résultats des interventions ».

Pour mener à bien les soins relationnels, une relation de confiance est une condition indéniable, suivant la capacité 5.3 « Établir avec l'individu sain ou malade, son entourage et/ou la collectivité une relation adaptée au contexte rencontré ». L'objectif même de ces soins est d'apporter un soutien psychologique. Cette compétence rejoint donc l'article 10 du code de déontologie.

1.3 Énoncer les concepts clés

Compte tenu de ce qui vient d'être présenté dans la situation vécue, l'image corporelle perturbée, le deuil et la relation d'aide sont des concepts centraux de la thématique.

Lorsqu'un individu subit une transformation corporelle telle qu'une stomie, la modification est telle que la manière dont ce dernier se perçoit va être altérée provoquant un véritable traumatisme psychologique. En effet, avec le placement d'une stomie, c'est tout le système digestif qui est modifié. Très jeune, nous avons appris la continence, car c'est ce qui est socialement demandé. Le système digestif et la continence ont dès lors une dimension physique et psychologique.

La stomie ne permet plus la même maîtrise, ou du moins cela nécessite un apprentissage. Le patient passe donc d'un état à un autre. Pour vivre en accord avec soi, le patient devra donc cheminer vers une acceptation de sa modification. Cela fait dès lors référence à un deuxième concept qu'est le deuil.

Le deuil et l'image corporelle perturbée sont deux éléments intimement liés. L'image corporelle perturbée entraîne une certaine souffrance chez le patient, telle que précisée à la page 6 dans les caractéristiques du diagnostic. Pour améliorer la représentation mentale de son image, le

patient devrait cheminer vers l'acceptation de son corps selon un processus que je vais analyser au chapitre suivant.

Finalement, le patient dans sa quête n'est pas seul et va rencontrer sur son parcours différents professionnels de la santé qui l'aideront dans son cheminement. Je m'attarderai ici à clarifier uniquement le rôle de l'infirmière en analysant le concept de soins relationnels. Outre les soins spécifiques à la stomie et l'éducation qui en découle, l'infirmière pourra être un support dans sa quête d'acceptation.

L'analyse de ces concepts permettra de poser des balises quant à l'analyse de mon interpellation. À savoir, la relation d'aide de l'infirmière dans un service aigu tel que la chirurgie, dans le but de soutenir le patient dans sa quête d'acceptation d'une modification corporelle.

2. Recherches et réflexion professionnalisante

2.1 Exploration des concepts

2.1.1 L'image corporelle perturbée

Avant de définir l'image corporelle perturbée, il me semble intéressant de pouvoir m'attarder sur la définition de ce qu'est l'image corporelle. Selon Woods cité par Salter (1992, p.2), « l'image du corps a été conceptualisée comme une image mentale de son propre corps, c'est-à-dire la façon dont le corps apparaît au moi. » En d'autres termes, l'image corporelle dépend de notre propre manière de percevoir notre corps.

Les auteurs Jonniaux, Hof et Dufour vont plus loin en reprenant Price, qui définit l'image corporelle selon trois composantes :

« ... le corps réel, le corps idéal et l'apparence... Le corps idéal est l'image mentale du corps rêvé et des prouesses qu'il devrait accomplir ... L'apparence est littéralement la façon dont on présente son corps au monde : la façon de s'habiller, de se coiffer, de marcher, de parler et même d'utiliser un appareil auxiliaire comme une canne ou un appareil auditif ». (2013)

Il y a rarement un alignement entre le corps réel et le corps idéal. Des ajustements de l'image corporelle sont donc possibles en fonction des critères qui les déterminent. De manière générale, ils sont en constante évolution. L'harmonie serait atteinte lorsque le corps réel, le corps idéal et l'apparence coïncident. (Aacovou, 2005)

Dans cette même philosophie, un diagnostic infirmier permet donc de faire le lien entre ces trois éléments allant dans le sens d'une altération. Pascal et Frecon Valentin définissent l'image corporelle perturbée comme « une confusion dans la représentation mentale du moi physique ». (2017, p.281) Il y a donc bien un déséquilibre entre le corps réel et le corps idéal. Dans d'autres situations, ce sont des handicaps ou des modifications corporelles qui vont impacter l'image que l'individu a de son corps.

Les attributs de ce concept sont multiples. Une image corporelle perturbée peut être vécue consciemment ou inconsciemment et sera provisoire ou définitive.

« Les caractéristiques principales étant l'expression de sentiments et/ou de perceptions reflétant une altération dans la représentation de l'apparence, de la morphologie ou de la fonction, la réaction non verbale à un changement réel ou perçu

affectant la morphologie et/ou une fonction, les comportements d'évitement, de surveillance ou de prise de conscience du corps... Le refus de regarder la partie du corps concernée, le refus de vérifier le changement réel, la dépersonnalisation de la partie malade ou manquante en la nommant par des pronoms démonstratifs impersonnels ». (Jonniaux et al, 2013).

Faisant référence aux antécédents, plusieurs éléments peuvent être à l'origine de ce mal-être. Dans son ouvrage sur l'image corporelle altérée, Salter (1994, p.4) propose des exemples de catégories d'antécédents d'altération d'image corporelle. Il peut s'agir de gestes chirurgicaux (stomie, cicatrices ...), de malformations congénitales, de traumatismes (brûlures, amputation...), vieillissement du corps... Ces éléments peuvent également être à la vue de tous ou plutôt cachées, telle qu'une incontinence. La poche de stomie quant à elle peut être tantôt discrète, cachée sous un vêtement tantôt visible lorsque la personne est en maillot de bain. Dès qu'elle se déshabille, la zone est « à découvert ». Et le regard du patient peut se poser aisément dessus.

Ces éléments sont les causes principales des altérations de l'image corporelle. Cependant, d'autres éléments ont un impact plus subtil sur cette même image du corps. Le regard des autres, dû aux habitudes de la société, la culture, la symbolique du corps véhiculé dans les médias, l'éducation sont des facteurs d'influence. (Salter, 1994)

De façon plus personnelle, les attitudes, les émotions, l'intelligence et les relations interpersonnelles, les expériences de vie, les systèmes de valeur et les croyances sont autant d'éléments qui influencent l'image corporelle et le niveau d'altération de l'image corporelle. (Aacovou, 2005)

Cette altération de l'image corporelle impacte la vie sociale, sentimentale et professionnelle des individus. Ce sont les conséquences qui découlent de ce concept.

« ...les différents changements peuvent avoir des répercussions très importantes notamment sur la vie sociale et professionnelle de la personne... » (Jonniaux et al, 2013, p.27). En effet, il est courant d'observer des personnes qui n'osent plus sortir de chez elles, elles s'isolent et se cachent de la société.

Par conséquent, cette vision négative du corps peut entraîner un processus de deuil. Il peut donc s'agir du deuil de son corps, d'une fonction vitale, d'une apparence, de sa propre représentation corporelle...

2.1.2 Le deuil

Selon les auteurs Kouriatis et Bronw, il s'agit de la perte de toute chose qui se termine et qui a du sens et de l'importance pour nous. Cela fait donc référence à tout type de perte qui a un grand impact sur les pensées, les croyances, les sentiments, les comportements et les relations de la personne avec elle-même et les autres. [Traduction libre] (2011)

Par ailleurs, la science infirmière dispose d'ailleurs d'un diagnostic infirmier, deuil, défini par Pascal et Frecon Valentin comme un « Processus complexe et normal qui comprend des réactions émotionnelles, physiques, spirituelles, sociales et intellectuelles par lesquelles les individus, les familles et les collectivités intègrent la perte réelle, anticipée ou potentielle dans leur vie quotidienne. » (2016, p. 186).

Pascal et Frecon Valentin (2016, p.186) détaillent les attributs suivants :

- « - Mort d'une personne affectivement importante ;
- Perte anticipée d'un objet considéré comme important (par ex. bien, emploi, statut)
- Perte anticipée d'une personne affectivement importante
- Perte d'un objet considéré comme important (par ex. bien, emploi, statut, maison, partie du corps). »

Plusieurs éléments caractérisent le deuil, quel qu'il soit. Premièrement, le deuil est presque toujours douloureux. Deuxièmement, il est présent pour des pertes toujours irréversibles. Dans l'exemple d'une modification corporelle, il ne s'agit donc pas d'un état temporaire, mais bien d'une perte définitive. (Kouriatis et Bronw, 2011)

À la lecture de la littérature, le premier mot synthétique est cheminement. Le deuil est un processus plus ou moins long. L'individu part d'un point de départ, la perte, et va vers un point final, l'acceptation du changement. Ce parcours comporte une série d'étapes qui seront vécues singulièrement par le patient. Cette idée de cheminement est un autre attribut caractéristique du concept de deuil.

Bons nombres d'auteurs et de spécialistes dont Kûbler-Ross se sont attardés sur ce concept du deuil afin d'en définir les étapes. Ces dernières sont d'abord le déni, la colère, le marchandage, la dépression et finalement l'acceptation. L'auteur Salter reprend Kûbler-Ross (1969) en expliquant que la première étape du deuil correspond à un refus de la perte. Ensuite, cette émotion va laisser place à la colère qui peut être dirigée envers l'entourage proche ou non proche du patient (la famille, les amis, les collègues, le médecin, les infirmiers ...). Au cours de la troisième étape, ce dernier va tenter de négocier avec la vie afin d'échapper à la situation. Par ce processus, le malade essaie de donner du sens à ce qui n'en a pas. La

dépression a lieu quand la personne se rend compte que le changement est irréversible. La tristesse et la souffrance sont alors immenses. Finalement, ces sentiments vont s'estomper dans le temps, laissant place à l'acceptation du changement. Les phrases-chocs de la patiente dans la situation peuvent correspondre à la phase de la colère ou encore de la dépression.

Pour terminer, les conséquences possibles du deuil peuvent être multiples selon les auteurs Zisook *et al.* (2014) :

- Mortalité et morbidité augmentée
- Trouble dépressif majeur
- Stress post-traumatiques et anxiété
- Abus de consommation de substance

De manière plus générale, le deuil peut laisser place ensuite à un chagrin ressenti comme ordinaire, mais également sous forme de chagrin compliqué ou deuil pathologique.

Pascal et Fracon Valentin parlent de deuil problématique lorsque « ... la détresse qui accompagne le deuil ne parvient pas à s'atténuer selon les normes prévues et se manifeste par des troubles fonctionnels » (2016, p.189). Pour Philippin (2006), le deuil compliqué s'écarte de la normalité, c'est-à-dire que la souffrance est augmentée en intensité et en temps, nuisant aux possibilités du travail de deuil de s'engager ou de parvenir à son terme. Il identifie des éléments comme étant déclencheurs de ce type de deuil dont notamment le suicide ou les tentatives de suicide telles que présentes chez la patiente. L'auteur Hanus va plus loin et précise que le deuil compliqué est présent lorsqu'il y a une décompensation d'une pathologie physique ou psychologique qui était déjà connue précédemment. À distinguer du deuil pathologique qui fait référence au développement d'une pathologie physique ou psychique qui aurait été jusqu'alors inexistante chez le patient. (Hanus, 2006)

Dans la situation vécue, madame présentait une grande dépression avec de multiples tentatives de suicide. Sous antidépresseur et antipsychotique, la pathologie mentale était bien présente et diagnostiquée avant la présence des différentes stomies. Par conséquent, cela nous laisse penser que nous nous trouvons dans une situation de deuil compliqué.

Il y a cependant lieu de préciser quelques éléments positifs pour le patient pouvant découler du processus de deuil une fois que celui-ci se termine. Des auteurs avancent le principe selon lequel le deuil peut aussi déboucher sur des conséquences positives pour le patient. La transformation corporelle pourrait augmenter la compassion, améliorer les relations, et la conscience existentielle de l'individu. [Traduction libre] (Brodin et Uveges, 2018)

2.1.3 La relation d'aide

Les grands auteurs des soins infirmiers se sont attardés à circonscrire la relation d'aide entre le soignant et le patient.

Selon Virginia Henderson (citée par Daydé et al, 2007, p. 38), l'infirmière a « la fonction d'interprète, c'est-à-dire aider le malade à se comprendre lui-même, à modifier les conditions qui le rendent malade et à accepter celles qui ne peuvent être changées ».

Jean Watson a également étayé la relation dans sa théorie du Caring. Elle précise que grâce à une exploration en toute confiance de l'autre, l'infirmière peut aider le patient à améliorer son état de santé, mental et/ou physique, en prenant conscience de sa situation actuelle. (Watson citée par Jacqmin, 2020).

Formarier (2007) quant à elle définit le concept tel qu' « ...une relation à visée thérapeutique qui a pour but d'aider, de façon ponctuelle ou prolongée, un patient (et/ou une famille) à gérer une situation qu'il juge dramatique pour lui... »

La relation d'aide se définit par différents attributs. Selon Watson (cité par Salter en 2017), afin d'établir une relation d'aide, l'infirmière doit être pourvue de certaines aptitudes telles que l'empathie, la chaleur humaine, l'écoute et l'ouverture d'esprit. Il sera également nécessaire de considérer la personne dans un ensemble, un tout holistique.

Si les qualités humaines de l'infirmière sont indéniables, la connaissance de son rôle propre est également importante, ce qui lui permettra d'analyser la situation de soin, en fonction de son pouvoir d'action. L'expérience sera également au service des soins relationnels.

De plus, selon Daydé et al (2007), la relation d'aide reposera sur une série de conditions permettant de rencontrer l'autre dans une dimension éthique :

- Le consentement de la personne prise en charge ;
- Le respect de la confidentialité ;
- L'engagement du patient à s'impliquer personnellement ;
- La possibilité, à tout moment, d'interrompre la relation ;
- La continuité des soins qui donne la garantie de ne pas être abandonné.

De façon pratique, la relation d'aide peut prendre différentes formes. Tantôt formelle, tantôt informelle, elle peut s'inscrire dans la durée ou de façon plus ponctuelle, et selon des étapes structurées, en utilisant les techniques de la communication.

Formarier identifie des antécédents à l'origine du mal-être du patient qui donneront suite à une relation d'aide. « ...[L'] annonce d'un diagnostic difficile, [l'] aggravation de la maladie, [la] fin de vie, [la] perte, [le] deuil, [la] souffrance, [la] maladie chronique, [l'] accident, ... Cette relation d'aide vise également des personnes qui sont confrontées (comme victime ou comme témoin) à des situations de crise violentes par leur intensité et leur survenue inattendue : Violence, viol, crise familiale, harcèlement, accident... » (2007).

De plus l'auteur précise que chaque individu dispose d'un seuil de tolérance différent qui donnera lieu à un besoin d'aide pour l'aider à traverser cette épreuve. Ce besoin d'aide apparaît généralement assez rapidement après les faits.

Hetu cité par Formarier (2007) identifie trois caractéristiques qui justifient la relation d'aide.

- 1) Une défaillance de la personne qui restreint son autonomie en limitant sa capacité à répondre aux exigences ordinaires du cadre social commun.
- 2) Cette défaillance intime induit un besoin d'aide de la part des institutions médicales ou sociales plus important que celui auquel répondent les aides ordinaires.
- 3) Ce besoin particulier articulé aux fragilités spécifiques de la personne enclenche une personnalisation de l'aide.

La relation d'aide si celle-ci repose sur des bases saines pourra apporter de multiples conséquences positives dans la vie du patient et de son entourage. Les auteurs Daydé et al. (2007) en énumèrent les principales.

Premièrement, grâce à l'écoute et la bienveillance de l'infirmière, le patient peut se sentir reconnu dans sa souffrance. Par ses rencontres, le patient va dévoiler au soignant ses émotions, ses choix, ses doutes, ses questionnements, se présentant comme un être singulier.

En fonction de son propre rythme, celui-ci pourra réfléchir sur lui et ses difficultés. Cette introspection permet de mieux se comprendre et se connaître ainsi que de donner du sens à ce qui lui arrive. Cette clarification pointe le doigt sur ce qui pose problème et trace le lien entre ses émotions et la situation.

De plus, grâce à la relation d'aide, le patient découvre ses mécanismes de défense. Le patient met alors en place ses propres solutions et les personnes-ressources.

En reprenant le contrôle de la situation, le patient reprend confiance en lui et en ses compétences. Il sera plus en mesure d'assumer ses décisions et d'être capable de parler à ses proches de ses difficultés.

Dans la situation interpellante, Madame cherche à tout prix à établir un contact avec l'équipe soignante. Elle présente une grande détresse et cherche à être entendue dans sa souffrance. Ses gestes, ses regards, et ses mots-chocs sont des signaux d'alarme d'une détresse. La relation d'aide avec un soignant sera un moyen d'exposer sa douleur afin de mieux comprendre et de trouver des solutions pour apprendre à vivre avec une telle modification corporelle.

2.2 La recension des écrits

Afin de parcourir la littérature existant en lien avec l'interpellation, j'ai utilisé l'outil de recherche informatique PUBMED. Différents mots clés, en français et en anglais sont à la base de cette recherche avec certaines combinaisons de ces derniers : altération de l'image corporelle, stomie, relation d'aide, stratégie d'adaptation, *coping*, *body image disturbance*, *stoma*, *nursing care*, *caring*. Quatre articles ont permis de dresser un tableau global sur la compréhension d'un diagnostic d'altération de l'image corporelle suite à une stomie ainsi que l'intervention de l'infirmière dans la relation d'aide.

La démarche en soins infirmiers repose sur une collecte des données efficaces, pour ensuite établir un plan de soins composés d'interventions. Dans cette philosophie, il me paraît important, dans un premier temps, de comprendre l'expérience du patient stomisé, car c'est sur cette base que l'infirmière pourra construire un plan de soins dans le but de soutenir le patient dans son acceptation. Dès lors, la prise de connaissance de l'ensemble des risques possibles à la suite d'une stomie est abordée.

Concernant le vécu des patients, il existe un nombre certain d'études quantitatives et qualitatives sur les conséquences néfastes d'une stomie sur la qualité de vie des patients, d'un point de vue physique et psychologique. Plusieurs études de synthèses ont aussi été réalisées.

Les auteurs Trabelsi, Abeljalil, Derbal, et Bougmiza ont retenu mon attention avec leur étude originale sur les stratégies d'adaptation des patients colostomisés qui vivent une perturbation de l'image de soi après un mois de chirurgie, réalisée en 2017. Il s'agit d'une étude observationnelle qualitative auprès de 70 patients stomisés ayant subi l'opération depuis plus d'un mois.

Dans cette dernière étude, les auteurs font le relevé de l'ensemble des conséquences négatives pour la vie du patient, allant de l'estime de soi altérée, aux problèmes conjugaux en passant par les troubles psychiatriques. Les conséquences de la stomie sont donc indéniables sur le quotidien des patients. Dans un premier temps, cette étude nous permet de comprendre l'impact précis sur les différents plans de leur vie.

Dans cet objectif d'accompagnement de la personne stomisée, les auteurs utilisent le modèle d'adaptation de Callista Roy, qui se fonde sur quatre modes : physiologique, concept de soi, fonction de rôle et l'interdépendance. L'objectif de cette étude est donc de comprendre ce que le patient met en place comme stratégie d'adaptation dans chacun de ces quatre modes. Premièrement, il y a lieu de présenter la définition des quatre modes de Roy, pour ensuite y ajouter les conséquences s'y rapportant selon les auteurs.

Le mode physiologique correspond à une « distorsion de ce schéma corporel et un changement de l'image du corps, amenant parfois le patient à délaisser cette partie du corps, et à la négliger. Ce changement visuel perturbe les patients. » (Trabelsi et al., 2017, p.100). Cela se manifestera par la fatigue, le manque de sommeil, la douleur, l'incontinence, le mal-être physique. Ces derniers éléments physiologiques se répercuteront sur le bien-être psychologique par de la révolte et de la colère. Ce point faisant d'ailleurs référence au processus de deuil évoqué dans les concepts. (Trabelsi et al., 2017)

Le concept de soi touche à la personne physique, mais aussi à l'image corporelle. Les conséquences de ce mode sont d'un tout autre ordre. À la suite du changement, les patients se sentent toujours malades, ils ne veulent pas voir ou toucher la stomie. Peu de patients intègrent cette transformation comme faisant partie de leur corps et ne se remettent pas du choc, entraînant de la colère et de l'inquiétude. Les émotions ressenties sont diverses ; la peur, la honte, l'inquiétude, le sentiment d'infériorité, les préjugés, se sentir indésirable sexuellement faisant suite à une perte de confiance et d'estime de soi. Les patients sont donc pris en otage de leurs émotions ayant l'impression de ne plus faire partie de la normalité, se manifestant par la peur du rejet. Dès lors, ils seront dans une sorte de lutte afin de retrouver une certaine forme de normalité. (Trabelsi et al., 2017)

« [Le mode fonction de rôle correspond à] ...des schémas de comportements appropriés à des situations déterminées ... [construits sur base de nos valeurs]. » (Trabelsi et al., 2017, p.101). Il peut s'agir de rôle familial (père, mère ...), social (amis, entourage, bénévoles ...) ou professionnel (employé, patron, collègue ...). La stomie et les conséquences vécues provoquent une réduction de leurs activités et par conséquent de leur rôle. (Trabelsi et al., 2017)

[Le mode d'interdépendance] ... se concentre sur les interactions liées au don et de réception de l'amour, le respect et la valeur. Le besoin de base de ce mode est l'intégrité relationnelle, ou le sentiment de sécurité dans le développement des relations. (Trabelsi et al., 2017, p.101).

Les patients sont réticents à s'intégrer socialement, car le stomisé a peur de la perception des autres sur leur stomie. Par conséquent, un entourage proche à l'écoute et soutenant a donc

un impact important sur l'acceptation et le bien-être. Si le soutien n'est pas présent, il s'adaptera difficilement. (Trabelsi et al., 2017)

L'analyse des conséquences étant établie, je peux faire un comparatif avec la situation vécue lors de mon stage. Madame présentait différents symptômes. J'avais observé beaucoup de colère, de dégoût et une dévalorisation d'elle-même correspondant au mode concept de soi.

L'expérience patient étant détaillée, la relation d'aide envers le patient stomisé et donc les actions qui peuvent être entreprises sont abordées.

Si les études sur les conséquences de la stomie sont très nombreuses, cela n'est pas vraiment le cas concernant l'analyse ou les recommandations concernant l'accompagnement du patient par l'infirmière afin de l'aider à s'adapter dans un contexte d'altération de l'image corporelle.

Dans l'article de Jonniaux, Hof et Dufour (2013), *l'image corporelle perturbée, quels objectifs et interventions en soins infirmiers ?*, les soins relationnels, les techniques de médiation corporelles afin d'aider le patient dans sa quête d'adaptation émotionnelle sont approchées. C'est donc dans ce contexte que va s'inscrire la relation d'aide, basée sur la confiance telle que définie dans l'analyse de concept. « Considérant la personne dans sa globalité, il s'agit de proposer un soin qui ouvre un espace d'expression (prendre soin du corps tout en se préoccupant du vécu de la personne. » (Jonniaux et al., 2013, p. 16)

Premièrement, ces auteurs fixent le cadre en posant l'objectif des interventions de soins, à savoir, l'exploration et s'intéresser au vécu de la personne, en utilisant diverses méthodes. Concrètement, il s'agit d'une récolte des données psychologiques et comportementales comprenant :

- La façon de vivre la maladie ;
- Les sentiments et les émotions ;
- Les représentations ;
- Les sensations corporelles du moment dans l'ensemble du corps ;
- La place du corps ;
- Les événements ayant pu s'inscrire dans le corps ;
- L'activité physique et sportive ;
- Les parties du corps les plus et les moins investies ;
- La manière et les mots utilisés pour parler du corps ;
- Les sentiments et les émotions ;
- L'impact sur l'identité de la personne. (Jonniaux et al., 2013, p. 17)

D'ailleurs, Aacovou *et al.* (2005) indique que la manière de récolter les informations sur l'image corporelle du patient peut être de différentes formes (questionnaire, entretien formel ...) en accordant une attention au langage non verbal. Les comportements d'évitement, les éventuelles négations du problème seront relevés. L'identification de ces éléments n'est pas évidente et se réalise de façon graduelle sur une période.

Face à ces répercussions, le soignant aide le patient à instaurer de nouvelles habitudes et des comportements adaptés à sa personnalité en fonction de ses capacités, ses envies ... La relation d'aide, présente dans ce cas, permet à l'infirmière de déceler les stratégies d'adaptations du patient. Avec la soignante, le patient peut donc identifier les stratégies qui peuvent être valorisées et renforcées. (Jonniaux *et al.*, 2013)

À ces soins relationnels, il ne faut pas oublier l'apprentissage et la maîtrise de l'appareillage, car l'acceptation passe aussi par une maîtrise de ces soins (changement, de poche, soins d'hygiène, adaptation de son alimentation ...). Au travers l'apprentissage, le patient apprivoise cette zone et se réapproprie son corps. (Jonniaux *et al.*, 2013).

La soignante peut également orienter le patient vers d'autres alternatives telle que la rencontre avec un patient ayant vécu une situation similaire (ou groupe de soutien). Cela permet au stomisé d'observer que d'autres personnes sont passées par là et peuvent lui donner des conseils sur son vécu. Il pourrait s'assimiler à lui et se rassurer. De plus, le toucher, la relaxation, la sophrologie (grâce à la décontraction musculaire, la tension psychique se détend), l'art thérapie, le photolangage (utiliser la photo plutôt que les mots) sont autant de techniques qui peuvent être conseillées afin d'extérioriser l'angoisse et accepter le nouvel état. (Jonniaux *et al.*, 2013).

Concernant le toucher, il en existe différents types ; le toucher relationnel, le toucher massage ou le toucher thérapeutique. Le premier, appelé également toucher présence est le fait de prendre le temps de laisser ses mains posées afin d'aider le patient à mesurer les limites de son corps. Ce contact intime doit s'inscrire dans un cadre sécurisant et confortable (respect de la pudeur, couverture, lumière douce, allongée ou assise en fonction ...). Les gestes dans le toucher massage, donneront place à une sensation plus agréable et donc réconfortant, alors que le patient n'a ressenti que de la douleur ou de la gêne à cet endroit. Martha Rogers a développé le modèle conceptuel du toucher thérapeutique, qui consiste à toucher la partie atteinte et à la verbaliser lors de soins tels que les soins d'hygiène, les pansements... (Jonniaux *et al.*, 2013).

D'ailleurs, les auteurs Aacovou et al. (2005), s'étendent également sur l'importance de se fixer des objectifs progressifs et réalisables pour le patient allant dans le sens de son acceptation. (Jonniaux *et al.*, 2013).

Le troisième article choisi est de l'auteur Borwell (2009) et s'intitule ; Continuity of care for the stoma patient: psychological consideration. Ce dernier apporte également un éclairage sur les soins relationnels et les interventions possibles en préopératoire et en postopératoire. Il est vrai que cet article de synthèse date de 2009, mais il permet d'avoir une vue d'ensemble en apportant un éclairage sur les interventions sur tout le parcours du patient stomisé allant du préopératoire jusqu'au postopératoire

Borwell (2009) précise l'importance d'une préparation et d'un accompagnement des patients en préopératoire. Les situations d'urgence ne permettent malheureusement pas toujours cette possibilité. Si le patient subit cette transformation en urgence, les conséquences psychologiques risquent d'être plus traumatisantes. Par conséquent, l'adaptation en sera d'autant plus difficile.

Tout comme le précisait Jonniaux *et al.* (2013), les soins postopératoires s'inscrivent dans une prise en charge multidisciplinaire et comprennent les grands points suivants :

- L'éducation et l'information du patient, mais aussi de toutes personnes qui entrent dans le soin de la stomie telle que la famille par exemple. L'objectif est de favoriser l'empowerement du patient et sa participation.
- L'indépendance du patient dans ses soins : en fixant un objectif général composé de petits objectifs réalisables en fixant des stratégies d'adaptation. L'implication du patient dans la réalisation de ses soins aura un effet bénéfique sur l'estime de soi et sa dignité. Borwell insiste sur la nécessité de favoriser la motivation du patient, sa satisfaction vis-à-vis de ses réussites et la mesure de son niveau de dépendance, est autant de points utiles à l'acceptation. (Borwell, 2009)

La sortie de l'hôpital est une période de transition très importante et délicate pour le patient. Il va se retrouver chez lui sans la présence et l'aide permanentes des soignants. L'ensemble des infirmières spécialisées (spécialisée en palliatif, en oncologie, en stomathérapie ...) grâce à leur coordination vont jouer un rôle dans des soins primaires et secondaires permettant de traverser cette période de transition. (Allison citée par Borwell, 2015). « La recherche a démontré le besoin de contact régulier et soutenant par des infirmières spécialisées, qui peuvent être présentes jusqu'à un an après l'opération » [Traduction libre] (Pringle and Swan cités par Borwell, 2015, p.328). Les auteurs présentent également l'importance d'un relai de l'information allant de l'équipe de soignants à l'hôpital vers les infirmières à domicile. Ceci

pouvant permettre d'établir l'évaluation psychologique et physique du patient utile à la planification des soins et des surveillances.

Concernant les répercussions psychologiques, la première étape pour l'infirmière sera de les identifier. Pour ce faire, l'infirmière doit faire preuve d'écoute et intervenir en faisant le lien entre le problème physique et le psychologique. Dans certains cas, lorsque la détresse psychologique est inextricable, ou que l'infirmière se sent dans une impasse, il est nécessaire de référer le patient à un professionnel de la santé mentale. (Borwell, 2015)

Le patient s'intègre dans un environnement social, au travers des contacts familiaux, amicaux, etc. Par conséquent, la stomie aura un impact sur le patient, mais également sur ses proches. Dans ce contexte, les proches jouent un rôle essentiel dans l'acceptation et l'adaptation de la personne stomisée. De plus, l'anxiété est générée principalement par la peur du regard des autres, de se sentir différents. Dès lors, l'infirmière intègre ces personnes dans la relation d'aide. Il en va de l'information, à l'éducation en faisant preuve d'écoute afin de rassurer, répondre à leurs doutes et interrogations, afin que ces derniers puissent être soutenant pour le patient.

Les stomies entraînent également des conséquences dans la vie sexuelle des patients. « Certains couples peuvent facilement accepter un arrêt de la sexualité, ou des limites dans les activités sexuelles ou des fonctions sexuelles modifiées, pour d'autres, un changement dans la vie sexuelle peut mener à une crise émotionnelle ». [Traduction libre] (Borwell, 2009, p.330). Les soins de nursing se doivent d'y prêter attention même si le patient n'en parle pas spontanément. La peur d'être jugé, ou simplement la pudeur sont des barrages à la communication du patient sur ce sujet. Grâce à la relation de confiance établie, l'infirmière a donc un rôle à jouer en abordant ce point en toute sécurité. Si le sujet ne met pas à l'aise l'infirmière, en avoir conscience est important. Dans ce cas, le patient peut être référé à un professionnel qui fournira le soutien nécessaire.

Au cours de mes recherches, j'ai découvert l'article de Aacovou de 2005, relatif au rôle de l'infirmière dans la réhabilitation des patients ayant un changement radical de leur image corporelle dû à des brûlures. Cet auteur établit directement le lien entre l'image corporelle perturbée et les phases de deuil. Bien que cet article ne traite pas directement des patients stomisés, et qu'il soit si ancien, son approche met en exergue le lien entre la modification corporelle et le deuil. Cette dimension n'a pas été « réactualisée » dans une étude plus récente.

Le patient passe par une série de 4 à 6 étapes, en réaction à son changement d'apparence physique. En fonction de chaque étape, le patient met en place des stratégies d'adaptation,

qui lui sont propres, afin de faire face à son émotion (anxiété, stress, dévalorisation ...). Il faut cependant être vigilant, l'infirmière pourrait avoir tendance à croire que l'individu passe par chaque étape consécutive et dans un même ordre. Or, chaque patient est unique dans sa manière de réagir face à la perte. Certaines étapes peuvent être présentes et d'autres non, et parfois même dans un ordre qui lui est propre. (Aacovou, 2005)

« Dans le but de fournir une relation d'aide au patient, l'infirmier a un triple objectif. Premièrement, l'objectif visé est la réhabilitation de leur santé physique. Le second est la bonne compréhension de son corps. Tandis que le troisième but est la réhabilitation psychologique ». [Traduction libre] (Aacovou, 2005)

Dans l'analyse de concept présentée au chapitre précédent, l'altération image corporelle a été définie selon la vision de Price. AACOVOU le reprend dans son article et s'en sert comme base pour ajuster l'intervention de l'infirmière selon les trois axes : le corps réel, le corps idéal et la représentation du corps.

- Le corps réel : concerne tout ce qui a trait aux besoins physiques et physiologiques du patient (ex : l'élimination de selle)
- Le corps idéal : permettre au patient de comprendre que son image corporelle est en transition, ainsi que son corps idéal. Le but est d'encourager le patient à parler de son ressenti par rapport à son corps idéal et l'aider à l'ajuster vers un niveau atteignable.
- La représentation du corps : sur ce point, l'infirmière aide le patient à atteindre une représentation pour laquelle ils ont un maximum de contrôle. Cela peut être atteint par un camouflage efficace de la stomie, qui aidera le patient à considérer la présentation de son corps comme socialement acceptable. [Traduction libre] (AACOVOU, 2005, p.89)

L'auteur a présenté d'une manière originale l'attention spéciale de l'infirmière pour les trois catégories mentionnées ci-dessus, en fonction de la période et des conditions dans lesquelles le patient se trouve. Cette présentation est propre aux patients brûlés, mais pourrait néanmoins être mise en parallèle avec un patient stomisé. Ce tableau met en lien le type d'attention que l'infirmière peut avoir en fonction de la période dans laquelle le patient se trouve par rapport à son traumatisme (les trois premiers jours après l'accident, 2 à 6 semaines après et quelques mois après).

	Patient's condition	Matters of special attention for the nurse		
		Body reality	Body ideal	Body representation
First 3 days after the accident	- critical condition, possible anaesthesia - swelling, hypovolaemic shock - stress, confusion, delirium, absence of feeling, disappointment - strong reactions of grief, feelings of guilt, incapacity, helplessness - shock therapy treatment	- supply of oxygen, protection of breathing tract - replacement of body liquids and ensuring the balance of electrolytes - care of wounds - protected environment - confinement of pain - observation of basic body functioning	- emphasis on needs of family and people supporting the patient - invasion of the vital space of patient's body - patient feels body as impersonal because of connection to medical devices - deprivation of the senses - the skin does not send the usual information and the patient feels loss of control	- conservation of dignity with respect to body exposure, wounds, and medical equipment - basic needs of health and care of body - need for clear communication - need to feel the body is succeeding in its presentation
2-6 weeks after the accident	- pain, swelling, patient regains control of most of body - patient leaves intensive care and stays in burns unit room - cataclysmic sensitivity outburst, anger, depression, withdrawal, enmity - problems of treatment of patient - partial help from family in care of patient - intensive physiotherapy - restoration of food intake	- care of wounds - first skin grafting operations - attempt to constrain skin contraction - control of pain - basic body functioning	- patients may withdraw or refuse to occupy themselves with body ideal - stressful reaction to realization of body changes - sensitivity to other people's reaction to appearance - worry about the future	- change of wounds - need to show improvement in appearance - need for children to play - appreciation of advantages of clothing - need to meet people - need to explain appearance - need to use special clothing or equipment or disguising materials
A few months after the accident	- some persistent pain - probability of contamination - side-effects of anaesthesia and surgery - physiotherapy and social work - long-term trauma - low self-esteem - danger of suicide attempt - danger of withdrawal - need for family to develop skills for helping the patient - need for socialization and need to control patient's contacts with other people	- surgery for reconstruction of parts of the skin - continuous physiotherapy - possible re-education for a new job - need for use of pressure bandages to contain scars - restoration of feeding habits - removal of medical equipment	- after discharge from hospital there may be diminished social support for the new body ideal - danger of developing social stigma - need to understand the limits of plastic surgery - need to have family support for new body ideal - need for new values and new criteria for self-evaluation	- need for supporting group - need for feeling comfortable in the group - need to re-establish relations of trust with family and friends - need for family support - need for sexual expression - change in the way of forming relations

Aacovou, The role of the nurse in the rehabilitation of patients with radical changes in body image due to burn injuries 2005

2.3 L'enquête exploratoire avec une personne-ressource

Afin de confronter la littérature scientifique avec la réalité de terrain, j'ai choisi de rencontrer une infirmière stomathérapeute. Cette dame a une expérience de 12 ans dans un service de chirurgie abdominale. Par la suite, elle a suivi la formation en stomathérapie. Depuis deux ans, elle reçoit les patients et leur famille en consultation, mais elle intervient également dans les services à la demande des équipes soignantes.

Dans son accompagnement, elle rencontre les patients soit lors des consultations, soit lors de ses visites dans les étages.

Concernant les consultations, l'infirmière rencontre le patient en préopératoire et en post opératoire (deux à trois fois dans le service de chirurgie, et une fois après la sortie de l'hôpital).

Ses visites dans les étages sont de trois natures. Soit la première visite est le jour de l'opération afin de répondre aux éventuelles dernières questions et dans le but de réaliser le marquage de l'endroit idéal où pourrait être placée la stomie pour un meilleur appareillage et confort du patient. Ensuite, l'infirmière rencontre les patients nouvellement stomisés. Elle sera également appelée par des services quelconques (gériatrie, revalidation...) pour des patients ayant une stomie qui posent des questions d'ordre pratique (matériels, surveillance de stomie ...).

Le patient est placé au centre d'une collaboration entre le médecin, l'équipe de soignante en service, la stomathérapeute, et le bandagiste. Concrètement, la collaboration concerne principalement le matériel nécessaire à la stomie. Avec le médecin, cela concernera surtout la durée de l'hospitalisation et de l'information à la stomie. Si elle ne considère pas le patient apte à retourner à domicile par manque d'autonomie, cet avis aura tout son poids dans la décision du médecin. La collaboration avec la psychologue est parfois possible pour des patients dont l'acceptation est particulièrement difficile.

Par contre, la collaboration entre la stomathérapeute et l'infirmière à domicile se fait plus rare. La stomathérapeute se rend disponible en remettant un dossier au patient avec des informations pratiques, le protocole de soin, le matériel utilisé et ses coordonnées afin de rester disponible pour l'équipe soignante à domicile. Dans des cas plutôt exceptionnels selon la personne rencontrée, l'infirmière à domicile prend contact avec elle afin d'avoir des détails sur la gestion de la stomie et surtout sur les raisons de changement de protocole ou de matériels. Cependant, il n'y a donc pas de contact direct à l'initiative de l'infirmière spécialisée.

De manière générale, le patient rencontrera une dernière fois la stomathérapeute un mois après l'opération environ et reste disponible pour toute demande par la suite. Lors de ce dernier rendez-vous, outre les surveillances de la stomie, elle veille à ce que le patient soit en sécurité vis-à-vis de ses soins, indépendamment de son besoin d'aide quant à son image corporelle.

Lors de ma rencontre, nous avons abordé l'accompagnement des patients dans la reconquête de leur corps. J'ai tenté de comprendre la manière dont elle les accompagnait afin de déceler des méthodes d'analyse des données, ainsi que ses interventions dans le but d'atteindre une meilleure image de son corps.

Cette infirmière stomathérapeute confirme l'importance d'une préparation en préopératoire. Lors de la rencontre, l'infirmière peut expliquer ou réexpliquer au patient l'objectif de l'opération, ce qu'est une stomie et comment la gérer par la suite. L'observation et l'écoute du patient sont capitales afin de savoir jusqu'où elle peut aller en termes d'informations. Pour certains patients, dès ce rendez-vous, elle pourra présenter les aspects pratiques de la poche

(comment vidanger, changer la poche, ou laver la stomie). Lever le voile sur les conséquences de la stomie à ce moment du parcours permet au patient de se préparer à la modification. Si bien qu'après l'opération le traumatisme est moins grand lors de la découverte de la stomie et de son appareillage.

Dans la revue de la littérature, la famille et les proches ont un rôle à jouer quant à l'acceptation et au cheminement du patient. Ce point est également essentiel pour la stomathérapeute rencontrée. Dans la majorité des cas, il s'agit du compagnon ou de la compagne du patient. Dans certains cas, c'est cette même personne qui réalisera les soins de la stomie. Avant tout et pour partir sur de bonnes bases, la stomathérapeute s'assure de l'accord de cette personne. A-t-elle conscience de ce que cela représente/implique dans sa vie ? Ensuite, une éducation sera réalisée sur la gestion pratique de la stomie.

Le toucher, et la vue d'une « nouvelle partie du corps » ne se réalisent pas vraiment lors des consultations dans son cabinet, mais plus tôt dans les étages de chirurgie. C'est lors des soins d'hygiène, de changement de poche, ou encore des pansements que l'infirmière prendra le temps, dans la limite du possible, d'aider le patient à regarder la stomie. Par contre, en consultation externe à l'hôpital, la stomathérapeute favorisera plus la conversation afin d'aider le patient à verbaliser ses difficultés.

Le sujet intime de la sexualité est abordé lorsque cela vient du patient lui-même. L'infirmière ne l'abordera pas spontanément. Dans le cas où le patient demande de l'aide sur ce sujet c'est principalement concernant le matériel qui pourrait l'aider (mini poche, bande ...).

L'infirmière présente donc une disponibilité en termes de temps, d'écoute active et de présence. Cependant les techniques abordées dans la littérature tels que le toucher, le massage, la sophrologie et autre ne sont pas réellement utilisées au décours des rendez-vous. L'accent est principalement mis sur l'accompagnement quant à la gestion pratique de la stomie (entretien, surveillance, utilisation du matériels, ...). Le diagnostic infirmier d'altération de l'image corporelle est connu mais ne débouche pas sur un accompagnement axé sur ce point précis. Les soins relationnels

Au cours de la discussion, j'ai pu constater que l'infirmière se base beaucoup sur son expérience et son savoir personnel en tant qu'infirmière de manière générale pour déceler les besoins des patients. « L'instinct professionnel » prend donc toute la place. L'écoute active est la principale source de renseignements. D'une part, pour déceler les besoins, inquiétudes ou questionnement. D'autre part, laisser le patient se livrer lui permettant de déposer son mal-être et de se décharger un peu de la douleur. Le deuxième « outil » principalement utilisé est

les techniques de communication qui l'aide beaucoup afin de clarifier ou aider le patient à trouver ses propres solutions.

Par contre, des outils tels que des échelles de mesure (des conséquences psychologiques, de l'estime de soi, de l'image de soi), des guidelines, et autres ne sont pas utilisés. L'identification de la phase de deuil du patient se fait de façon spontanée sans verbaliser ou identifier l'étape de façon précise.

De plus alors que la littérature précise l'importance d'identifier les stratégies de coping du patient, cela n'est pas évident sur le terrain selon la personne rencontrée, dont les raisons n'ont pu être identifiées. Dans les faits, cela serait plutôt le rôle du psychologue, rencontré la plupart du temps à l'initiative du patient. Le stress lié au traumatisme étant soulagé par la stomathérapeute grâce à son écoute, sans tenter de faire émerger des solutions, considérant son travail terminé lorsqu'elle pense que le patient est en sécurité.

3. Synthèse, questionnement professionnel et pistes de réflexion

Au cours de la prise en charge d'une patiente, j'ai été décontenancée quant à la demande d'aide de la patiente concernant sa modification corporelle. En effet, au cours de mes études, j'ai appris que ce type de traumatisme pouvait amener le patient à se sentir atteint dans son image corporelle. Cependant, je me suis sentie désarmée quant à la prise en charge du patient.

Afin de bien comprendre l'expérience patient, le diagnostic infirmier de l'altération de l'image corporelle a été défini en tant que concept. De plus, la perte d'une fonction corporelle peut entraîner un processus de deuil. Le patient cheminant à travers différentes étapes, avec des émotions et des questionnements précis. J'ai donc analysé le concept de deuil. Finalement, face à ce diagnostic et au deuil du patient, l'infirmière a un rôle à jouer. On parle de relation d'aide. Ce dernier concept est analysé afin d'en déterminer les contours.

Au travers de la revue de la littérature, quatre articles ont été analysés. D'une part, ces derniers m'ont permis d'augmenter mes connaissances de l'expérience patient lorsqu'ils sont atteints dans leur image corporelle. D'autre part, différents auteurs ont présenté des méthodes, ou pistes quant à la prise en charge. Mon interpellation de départ concerne les patients stomisés, cependant ce diagnostic peut être présent pour d'autres raisons telles que des grands brûlés par exemple. Un des textes fait référence à ce type de patient. Les recherches scientifiques relatant des interventions mettent l'accent sur une prise en charge holistique des patients. D'ailleurs, l'avis de l'infirmière rencontrée va dans ce même sens quant à cette approche. On parle de soins à la stomie (pansement, surveillance, matériels ...), mais aussi de leur vie sexuelle, sociale, sans oublier l'entourage proche du patient.

Tandis que la littérature présente une prise en charge assez variée (différentes techniques) et outillée des patients, l'infirmière utilise surtout son expérience basée sur l'observation et l'écoute active empreinte d'empathie. Sur base de ma rencontre et de mes lectures, je considère l'infirmière comme un facilitateur à mobiliser les forces internes du patient. Elle fait revenir à la conscience les ressources personnelles de ce qu'il y a au fond d'eux pour aller vers l'acceptation.

L'infirmière stomathérapeute insiste principalement sur l'importance de faire participer progressivement le patient au soin. C'est principalement au travers de ces soins qu'il peut apprendre à se réapproprier son corps et tendre vers une acceptation. Les interventions de l'infirmière n'agissent pas toujours directement sur l'image corporelle, mais se répercutent sur cette dernière. En effet, l'infirmière conseillera plus volontiers au patient de consulter un

psychologue plutôt que de se lancer dans une identification de son deuil et d'y travailler directement ensemble, grâce à des techniques existantes.

Grâce à un outil pratique et professionnel, le NANDA, l'infirmière peut trouver un ensemble de techniques à utiliser afin d'identifier les stratégies d'adaptation pour les mobiliser. Ceci dans le but d'aller un pas plus loin dans l'accompagnement outre la présence et l'écoute.

La relation d'aide que l'infirmière met en place peut trouver sa source dans l'évaluation concrète du patient concernant son image corporelle. De la sorte, afin d'objectiver son ressenti l'infirmière pourrait utiliser des échelles telles que, image corporelle, estime de soi, ou encore stratégies d'adaptation. Sur base des caractéristiques du patient (langage verbal, langage non verbal), la soignante place le curseur de ces différentes échelles. Ces dernières peuvent être scorées en début d'accompagnement et ensuite être réévaluées au cours des rencontres afin de suivre l'évolution. Par conséquent, ces échelles rendent légitime la relation d'aide et guide l'infirmière sur les besoins du patient.

Dans ce travail, j'ai la vision de l'infirmière et de la littérature scientifique sur le sujet. Néanmoins, cela éveille le besoin de mieux connaître le vécu des patients quant à la manière dont ils ont atteint une acceptation. Quels sont les leviers chez l'infirmière qui les ont aidés à accepter leur corps ? À l'inverse, il pourrait être intéressant d'identifier les éléments qui font barrage à une prise en charge directe de l'image corporelle du patient ? La littérature nous démontre différentes techniques telles que le toucher, les massages ... Pourquoi ces dernières ne peuvent être utilisées ? Et par conséquent, comment pourrions-nous les mettre en pratique ?

Afin d'apporter un cadre, ou un *guidelines* au soignant afin de les guider dans leur pratique auprès de patients stomisés atteints dans leur image corporelle, il pourrait être envisageable d'élaborer un modèle de base d'interventions possible. Dans son article abordé au point précédent, Aacavou présente un tableau des interventions en fonction de la période et des conditions du patient souffrant de brûlures. À l'aide du NANDA et d'autres études sur l'expérience, un tel tableau serait réalisable pour le type de patients visés par ce travail. Ceci pourrait représenter une sorte de guide permettant à toute infirmière d'agir directement sur l'image corporelle.

Conclusion personnelle

À l'issue de ce travail de fin d'étude, j'ai pu mesurer l'ampleur de l'expérience vécue par le patient face à un traumatisme du type de la stomie. Outre le bouleversement physiologique, l'équilibre vis-à-vis de son image corporelle est fortement ébranlé.

L'infirmière est donc la première personne spectatrice de ce changement, mais également la première personne à faire le lien entre le patient et ce changement physique et psychologique. Elle tient donc un rôle de suppléance, mais aussi de soutien psychologique.

Afin que le patient retrouve du sens et accepte le changement inéluctable, cette dernière peut aider le patient à puiser en lui les forces nécessaires, par différents moyens. L'éducation à la surveillance, à l'entretien et à l'utilisation du matériel semble être évidente, et a un impact sur l'acceptation du patient. Il y en a bien d'autres actions plus subtiles telles que le toucher, le massage, la sophrologie, l'écriture qui sont possibles et qui semblent être plus rarement utilisées. Cela peut concerner tous types d'infirmières, qu'elles soient stomathérapeute ou travaillant dans un service hospitalier ou à domicile.

Sa présence et l'éducation au patient prends également tout son sens en préopératoire afin de le préparer au mieux, lorsque c'est possible et ainsi limiter le choc.

Au cours de ce travail, j'ai pu analyser des articles scientifiques et me plonger dans la littérature professionnelle infirmière, aiguisant mon esprit d'analyse. La littérature représentant une mine d'or d'informations, et peut apporter bons nombres de réponses face à la relation d'aide. Cependant, je me suis rendu compte que les infirmières sur le terrain utilisent énormément leurs savoirs personnels (expérience), en faisant référence à leurs propres intuitions pour la pratique des soins relationnels. Elles n'utilisent pas d'outils, d'échelle de mesure ou autres techniques pour évaluer leur deuil, leur niveau d'acceptation ou même les aider sur leur image corporelle. Ce n'était donc pas évident de comprendre ce qu'elles mettent réellement en place auprès des patients quant à leur image corporelle.

Finalement, ce travail m'a permis de comprendre que les soins relationnels sont très personnels et dépendent de la personne que nous sommes, en tant que soignante. Nos connaissances et nos compétences sont capitales, mais notre rapport à l'autre et à sa souffrance, ou même à notre propre corps influence les soins. Cependant, avoir une attitude de réflexion par rapport à son propre rôle et la remise en question sur ce que l'on apporte au patient peut nous orienter vers « la théorie » ou la recherche afin d'apporter de l'objectivité dans notre accompagnement. Car j'ai l'intime conviction que nous avons un rôle plus important à jouer au-delà de notre simple écoute active et notre présence.

Finalement, la rencontre avec une personne-ressource à ses limites, car cela n'apporte qu'une seule expérience et une seule vision de l'accompagnant du patient. Je me suis donc sentie limitée quant aux informations reçues duquel on ne peut tirer aucune conclusion, aucune généralité. Ce qui ne serait le cas d'une étude qualitative avec un échantillon de différentes soignantes. Voilà qui ouvre la piste vers d'autres questionnements.

Liste de références

- Aacovou, I. (2005). The role of the nurse in the rehabilitation of patients with radical changes in body image due to burn injuries. *Annals of burns and fire disasters*, 18(2), 89.
- Arrêté royal du 10 mai 2015 portant coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. (2015). Moniteur belge, 18 juin 2015. Récupéré de :http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2015/06/18_1.pdf#Page2
- Borwell, B. (2009). Continuity of care for the stoma patient: psychological considerations. *British journal of community nursing*, 14(8), 326-331.
- Broden, E. G., Uveges, M. K. (2018). Applications of grief and bereavement theory for critical care nurses. *AACN advanced critical care*, 29(3), 354-359.
- Daydé, M.-C., Lacroix, M.-L., Pascal, C., Salabaras Clergues, E. (2007). Relation d'aide en soins infirmiers. Issy-les-Moulineaux, France.
- Fasse, L., Sultan, S., et Flahault, C. (2014). Le deuil, des signes à l'expérience. Réflexions sur la norme et le vécu de la personne endeuillée à l'heure de la classification du deuil compliqué. *L'Évolution Psychiatrique*, 79(2), 295-311. <https://doi.org/10.1016/j.evopsy.2013.03.002>
- Formarier, M. (2007). La relation de soin, concepts et finalités. *Recherche en soins infirmiers*, (2), 33-42.
- Hanus, M. (2006). Deuils normaux, deuils difficiles, deuils compliqués et deuils pathologiques. In *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique*, 164 (4), 349-356. Elsevier Masson. <https://doi.org/10.1016/j.amp.2006.02.003>
- Jonniaux, S., Hof, F. Dufour, O. (2013). L'image corporelle perturbée, quels objectifs et interventions en soins infirmiers ? *Soins*, 776, 16.
- Jonniaux, S., Hof, F. Dufour, O. (2013). L'image corporelle perturbée, pour la clinique centrée sur la personne soignée. *Soins*, 775, 27.
- Haute Ecole Robert Schuman (2022). Référentiel de compétences professionnelles du bachelier : infirmier responsable de soins généraux. Libramont, Belgique.
- Kouriatis, K., Brown, D.(2011). Therapists' bereavement and loss experiences: A literature review. *Journal of Loss and Trauma*, 16(3), 205-228. <https://doi.org/10.1080/15325024.2010.519289>

- Formarier, M., (2012). Aide (relation d'). Dans Formarier, M. , Jovic, L. (dir.). (2012). *Les concepts en sciences infirmières (2ème éd.)*. (pp. 61-64). Mallet Conseil.
- Pascal, A., Frecon Valentin, E. (2016). *Diagnostics infirmiers, interventions et résultats*. Issy-les-Moulineaux, France.
- Philippin, Y. (2006). Deuil normal, deuil pathologique et prévention en milieu clinique. *InfoKara*, 21(4), 163-166. <https://doi.org/10.3917/inka.064.0163>
- Salter, M. (1992). *Altération de l'image corporelle, le rôle de l'infirmière*. Interéditions, France.
- Trabelsi, F., Abeljalil, S. B., Derbal, F., & Bougmiza, I. (2017). Les stratégies d'adaptation des patients colostomisés qui vivent une perturbation de l'image de soi après un mois de chirurgie. *Recherche en soins infirmiers*, (2), 89-103.
- Tagkalakis, P., Demiri, E. (2009). A fear avoidance model in facial burn body image disturbance. *Annals of burns and fire disasters*, 22(4), 203.
- Union générale des infirmiers de Belgique. (2017). Code de déontologie des praticiens de l'art infirmier belge. Diegem, Belgique. Récupéré de : <https://auvb-ugib-akvb.be/fr/publications/code-de-deontologie/>
- Zisook, S., Iglewicz, A., Avanzino, J., Maglione, J., Glorioso, D., Zetumer, S., ... & Shear, M. K. (2014). Bereavement: course, consequences, and care. *Current psychiatry reports*, 16(10), 482. DOI 10.1007/s11920-014-0482-8

Je soussigné Cop Fanny autorise les membres de la Cellule d'Encadrement Méthodologique des Travaux de Fin d'Etudes à utiliser la version électronique de mon Travail de Fin d'Etudes et ce à des fins pédagogiques.

Date et signature(s) (précédé de la mention « Lu et approuvé »)

23 mai 2022
lu et approuvé
